



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : غاده خليل حلمي فهميم

العنوان : ...

الحي / المدينة : امبابه

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 24-09-2026

رقم البطاقة : 28806252101241 رقم التليفون : 01206260969

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-06-1988 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----

التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- / أ.د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: غاده خليل حلمي فهم National ID: 28806252101241	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

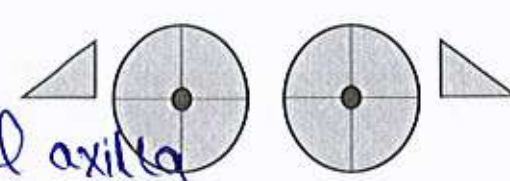
التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



MDT FORM 22/4/2026 G

Name	غادة خليل حليم	MRN	٤٨٦٧
Age	٣٧ سنة	ID	
Menopausal status	Pre menop.	Phone	
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC G2	R	L
ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: -ve
Ki67:		
Sonomammography:		
10/2024: MBC to contralateral axilla & bone (by e.Ts)	TNM	
Mets Workup: bone scan. → Free		
Started AI + Zoladex + Zometa 13m		
4/2026: CT: RD of lymph node		

Recommendations: SD of Rest

4/2026: bone scan: met. bone newly developed

For 2nd line.

to Zoladex / T-bone / 26/26

MDT OUTCOME & PLAN

to Zoladex / T-bone / 26/26

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

23/10/2024, 12:54

code 42 -- Name_A MDT (on Hainnal) -- Name_E MDT (on Hainnal)



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: **د. محمد علي محمد**

Sex:

3- Medical number:

Female

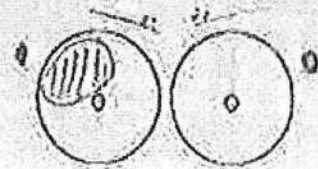
81221055

01/11/2024

23/10/2024

2- ID number:

Patient Age: 36 Y



Family history:

Family history:

Phone:

Tumor:

01002245958

BMI:

RT:

REASON OF NOT

REASON OF NOT

marital status:

Marital status:

NBS Score:

NBS Score:

GROUP:

GROUP:

Date of MDT:

Date of MDT:

Co-morbidity:

Co-morbidity:

Menopausal status:

Menopausal status:

INITIAL STAGE:

INITIAL STAGE:

23/10/2024

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

Mets status: equivocal. It is no lesion

DX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	8/8	Her 2 Neu	SISH	10
EXPLANATION	EXPLANATION	EXPLANATION	EXPLANATION	EXPLANATION	EXPLANATION
rt GII & extensive					

T	N	M
4b	3c	1 bone and contralateral axilla

Sonomammography

cesm: rt UOQ 9-12 o'clock 52 x22 mm reaching nipple & 6-7 o'clock 6x3.5 mm

+ve axillary LN +ve supracavicular LN

lt level I, II axillary LN --> mets from rt side

rt iliac bone mixed lytic & sclerotic lesion

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

ONCOLOGY & RX

start 1st line Zoladex + A1, 4 tamoxifen every 3 months with regular clinical assessment.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	<i>[Signature]</i>	RADIOLOGY	<i>[Signature]</i>
SURGERY	<i>[Signature]</i>	PATHOLOGY	<i>[Signature]</i>
Psychiatric	<i>[Signature]</i>	Nutrition	<i>[Signature]</i>

Patient Name : الأستاذة / د. د. خليل حليم فهد
Patient No. : 28806252101241
Path No. : 2300/24
Sex : Female
Age : 36 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001432
Request Date : 08/07/2024
Verification Date : 14/07/2024
Financial Category : برنامج التأمين - ممرض
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 10 O'clock mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 07/07/2024.

Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma.
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
Ductal carcinoma in situ: Extensively detected.
Perineural invasion: Not detected.
Angiolymphatic invasion: Not detected.

Diagnosis:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, with extensive DCIS.
Further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Esraa Magdy.

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 24/07/2024 13:09:54

Page 1 of 1

Printing By : Marwa Mohamed Younis



Patient's Name: Ghada khalil helmy fahmy
Date: 2026-03-24
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE
CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:**

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported right breast carcinoma.

Compared to the last study dated 29-11-2025 ,the current study revealed .

(I) Chest:

- Right breast lesion couldn't be appreciated at current study

Regressive course regarding :

- Right enlarged axillary lymph nodes , the largest measures 2 x 1.7cm compared to 2.3 x 2 cm
- Enlarged left axillary lymph nodes , the largest 17 x 10 mm compared to 20 x 19mm.
- Bilateral lower lobar mosaic attenuation of small airway disease.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

Patient's Name: Ghada khalil helmy fahmy
Date: 2026-03-24
Referred by: Prof.Dr. cap+c
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- The liver is enlarged in size showing homogenous CT density no hepatic focal lesions .
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions ,.
- No vertebral structural collapse .

OPINION:

- Regressive course regarding size of bilateral axillary lymphadenopathy .
- Rather stationary course of rest of study

Dr.Reham Khedr, MD

Name : Ghada Khalil Helmy Fahim

Date : 23-03-2026 08:43

Branch : Dokki

Medical No. : 334788

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعاقد مستشفيات

ISOTOPIC BONE SCAN REPORT

- **Indication:** 37-year-old female with history of breast carcinoma, presenting with bone aches. Evaluation for possible osseous metastatic disease.
- **Imaging Protocol:** Whole-body planar images (anterior and posterior projections) acquired approximately 2–3 hours post intravenous injection of the tracer (Tc-99m MDP).

FINDINGS:

- Mild abnormal radiotracer uptake is noted along the posterior aspect of the left 10th rib as well as the right sacroiliac region, where metastatic etiology remains a primary consideration.
- No other osseous lesions are identified throughout the remainder of the skeleton.
- Age-related degenerative/arthritis changes are noted in the spine, sternum, both shoulders, and weight-bearing joints.

IMPRESSION:

- Two worrisome osseous lesions as described, likely metastatic, for radiological correlation and clinical follow-up.
- No other osseous lesions elsewhere.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

Patient Name: Ghada Khalil Helmy
Prof. Dr: Center Hormal
Accession: 240905004

Patient ID: 684855
Exam Date: 7/9/2024

^{99m}Tc-MDP whole body bone scan

Desired information:

- ⊖ Skeletal surveying

Technique:

- ⊖ Anterior and posterior Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after 1. administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP;

Report:

Delayed static phases:

- ⊖ Active tracer uptake s noted at the left 10th rib posteriorly for CT correlation ?? traumatic ?? otherwise.
- ⊖ Mild degenerative changes are noticed in the dorsal & lumbar vertebrae.
- ⊖ Otherwise, no hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the rest of surveyed skeleton.
- ⊖ Both kidneys are visualized.

CONCLUSION:

- ⊖ Equivocal left 10th rib lesion for CT correlation to exclude serious nature.
- ⊖ Follow up bone scan is advised.

Best regards;
Dr. Huda Fathy M.D.